

TEMA 7.16 • NEFROLOGÍA

Síndrome Polidípico Poliúrico

PERFIL EUNACOM 1.10.1.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

El **Síndrome Nefrótico** no es una enfermedad en sí misma, sino una manifestación clínica de diversas patologías glomerulares. Estas se dividen principalmente según su histología y el grupo etario al que afectan. A continuación, se detallan las causas más frecuentes y sus características clave para el examen EUNACOM.

1. Enfermedad de Cambios Mínimos (ECM)

También conocida como **Nefrosis Lipoidea**, es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en la edad pediátrica (especialmente entre los 5 y 10 años).

NOTA CLÍNICA

Su nombre se debe a que, en la **microscopía óptica (MO)**, el glomérulo parece completamente normal. El diagnóstico definitivo requiere **microscopía electrónica (ME)**, donde se observa la **fusión o desaparición de los pedicelos** (prolongaciones de los podocitos).

Clínica: Se presenta como un **síndrome nefrótico puro** (sin hematuria, sin hipertensión y con función renal conservada). **Manejo:** En niños, no se realiza biopsia de entrada. Se inicia una **prueba terapéutica con corticoides** (Prednisona). **Dosis:** 60 mg/m² (máximo 60-80 mg/día) por 4-6 semanas. Luego se baja a 40 mg/m² para completar 2 a 3 meses de tratamiento. **Pronóstico:** Suele ser autolimitada y responder muy bien a los corticoides.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Si un niño con sospecha de ECM **no responde al tratamiento con corticoides** tras completar el esquema inicial, es obligatorio realizar una **biopsia renal** para descartar otras patologías como la GEFS.

2. Nefropatía Membranosa

Es la causa más frecuente de síndrome nefrótico puro en el **adulto**. También se le llama **glomerulopatía extramembranosa**.

Etiología: Puede ser idiopática (primaria) o secundaria a: **Fármacos** (AINEs, sales de oro, penicilamina). **Infecciones** (Hepatitis B). **Neoplasias** (tumores sólidos). **Enfermedades autoinmunes:** Es la forma de afectación renal en el **Lupus Eritematoso Sistémico** clase V. **Diagnóstico:** Se asocia a la presencia de anticuerpos **anti-PLA2R** (receptor de fosfolipasa A2). En la biopsia se observa un engrosamiento de la membrana basal con formación de "spikes". **Clínica:** Instalación rápida del edema y la proteinuria.

3. Nefropatía Diabética

Es una complicación crónica de la **Diabetes mellitus tipo 2** y tipo 1. Es la causa más común de enfermedad renal crónica terminal en el mundo occidental.

Clínica: A diferencia de la membranosa, es de **lenta instalación** y **progresión**. **Requisito clínico:** Habitualmente el paciente tiene más de 10 años de evolución de su diabetes y presenta otras complicaciones microvasculares (como retinopatía diabética).

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Si un paciente diabético desarrolla un síndrome nefrótico de **forma brusca** o lleva muy poco tiempo de evolución con su diabetes (ej. 1 año), se debe sospechar que la causa **NO** es la diabetes, sino una **Nefropatía Membranosa** sobreañadida.

4. Glomerulonefritis Mesangiocapilar (Membranoproliferativa)

Es una patología que puede presentarse tanto en adolescentes como en adultos jóvenes.

Clínica: Se caracteriza por ser un **síndrome nefrótico impuro** (suele acompañarse de hematuria y deterioro de la función renal). **Laboratorio:** Es una de las causas clásicas de **hipocomplementemia** (C3 bajo). **Particularidad:** Al igual que la **Nefropatía por IgA**, suele exacerbarse o debutar en conjunto con **infecciones respiratorias**.

5. Glomerulosclerosis Focal y Segmentaria (GEFS)

Se caracteriza por la cicatrización (esclerosis) de algunas partes (segmentaria) de algunos glomérulos (focal).

Asociaciones clásicas: Infección por **VIH/SIDA**. Consumo de heroína. Obesidad mórbida. Raza negra. **Clínica:** Suele ser un síndrome nefrótico puro, pero con mayor tendencia a la insuficiencia renal progresiva en comparación con la ECM.

Comparativa de Etiologías del Síndrome Nefrótico

TABLA 7.16.1: PATOLOGÍA VS POBLACIÓN TÍPICA

PATOLOGÍA	POBLACIÓN TÍPICA	PUREZA DEL SÍNDROME	HALLAZGO CLAVE
Cambios Mínimos	Niños (5-10 años)	Puro	Fusión pedicelos (ME)
Membranosa	Adultos	Puro	Anti-PLA2R / Lupus V
Diabética	Diabéticos de larga data	Puro	Progresión lenta
Mesangiocapilar	Jóvenes	Impuro	Hipocomplementemia (C3)
GEFS	Adultos / VIH+	Puro	Esclerosis focal

Resumen de Perlas EUNACOM

PERLA CLÍNICA EUNACOM

- **Niño con síndrome nefrótico:** Siempre pensar primero en **Cambios Mínimos**. No biopsiar de entrada; tratar con corticoides. - **Adulto con síndrome nefrótico puro:** Pensar en **Nefropatía Membranosa**. - **Adulto con síndrome nefrótico impuro + C3 bajo:** Pensar en **Mesangiocapilar**. - **Fisiopatología de ECM:** No se pierden los podocitos (la célula permanece), se pierden los **pedicelos** (las prolongaciones). - **Relación con Infecciones:** La **Mesangiocapilar** se descompensa con infecciones respiratorias, similar a la enfermedad de Berger.

Algoritmo de Diagnóstico en Pediatría

- **Diagnóstico clínico:** Edema, proteinuria de rango nefrótico, hipoalbuminemia.
- **Tratamiento inicial:** Prednisona 60 mg/m²/día.
- **Evaluación de respuesta:**
 - Si responde (desaparece proteinuria): Diagnóstico presuntivo de ECM. Seguir esquema de descenso.
 - * Si **no responde** (Corticorresistencia): Realizar **Biopsia Renal** para buscar GEFS u otras causas.

Insuficiencia Renal Aguda Insuficiencia Renal Crónica Examen de Orina Completo

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Paciente con poliuria y polidipsia. Glicemia normal. Se realiza test de la sed: tras 8 horas de privación de agua, la natremia se eleva a 152 mEq/L y la osmolaridad urinaria permanece en 120 mOsm/kg. Se administra desmopresina y la osmolaridad urinaria sube a 650 mOsm/kg. ¿Cuál es el diagnóstico?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Síndrome Polidíptico Poliúrico. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Estudio: glicemia (descartar DM), test de la sed (polidipsia vs DI), test de desmopresina (central vs nefrogénica).
- Polidipsia primaria: al privar de agua todo se normaliza.
- Diabetes insípida: al privar de agua aparece hipernatremia con orinas persistentemente diluidas.
- DI central: mejora con desmopresina. Tratamiento: desmopresina nasal.
- DI nefrogénica: NO mejora con desmopresina. Tratamiento: agua + hidroclorotiazida + AINEs.
- DI central: causas = TEC (la más importante), tumores, cirugía cerebral.
- DI nefrogénica: causas = litio (la más importante), hipercalcemia severa.
- Paciente psiquiátrico con litio: puede tener polidipsia psicógena O DI nefrogénica por litio.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (SÍNDROME POLIDÍPTICO POLIÚRICO)**PREGUNTA 1**

Paciente con poliuria y polidipsia. Glicemia normal. Se realiza test de la sed: tras 8 horas de privación de agua, la natremia se eleva a 152 mEq/L y la osmolaridad urinaria permanece en 120 mOsm/kg. Se administra desmopresina y la osmolaridad urinaria sube a 650 mOsm/kg. ¿Cuál es el diagnóstico?

- A)** Polidipsia psicógena
- B)** Diabetes insípida central
- C)** Diabetes insípida nefrogénica
- D)** Diabetes mellitus tipo 2
- E)** SIADH

PREGUNTA 2

Paciente bipolar en tratamiento con litio presenta poliuria de 5 litros diarios. ¿Cuáles son los dos diagnósticos que hay que diferenciar?

- A)** DM tipo 2 y DI central
- B)** Polidipsia psicógena y diabetes insípida nefrogénica
- C)** SIADH y DI central
- D)** DI central y DI nefrogénica
- E)** Nefropatía diabética y síndrome nefrótico

PREGUNTA 3

¿Cuál es el tratamiento de la diabetes insípida nefrogénica?

- A)** Desmopresina nasal
- B)** Restricción hídrica severa
- C)** Agua abundante + hidroclorotiazida + AINEs
- D)** Furosemda para reducir volumen urinario
- E)** Espironolactona

RESUMEN: SÍNDROME POLIDÍPTICO POLIÚRICO

El síndrome polidíptico poliúrico se estudia con tres exámenes: glicemia de ayuno (descartar DM, la causa más frecuente), test de la sed (diferencia polidipsia primaria de diabetes insípida) y test de desmopresina (diferencia diabetes insípida central de nefrogénica). En la polidipsia primaria (psicógena), la natremia basal es normal o levemente baja, orinas diluidas. Al privarlo de agua, todo se normaliza. En la diabetes insípida, la natremia basal tiende a la hipernatremia, orinas diluidas. Al privarlo de agua, aparece hipernatremia y las orinas se mantienen diluidas. El test de desmopresina diferencia la central (mejora con desmopresina, le faltaba ADH) de la nefrogénica (no mejora, el riñón no responde a ADH). La central se trata con desmopresina nasal. La nefrogénica se trata con agua abundante más hidroclorotiazida y AINEs para reducir volumen urinario. Causas principales: DI central = TEC, tumores, cirugía cerebral. DI nefrogénica = litio (la más importante), hipercalcemia.